BONUS 2

Startgids voor 6 stages

Neuro, Thorax, Abdomen, Musculoskeletaal, Kinderradiologie en Interventie/Mamma: wat je op de eerste dag van elke stage moet weten, de 10 meest voorkomende onderzoeken, typische fouten en de checklist voor de eerste week.

Inhoud

Hoe gebruik je deze gids

Stage 1 · Neuroradiologie

Stage 2 · Thoraxradiologie

Stage 3 · Abdominale radiologie

Stage 4 · Musculoskeletale radiologie

Stage 5 · Kinderradiologie

Stage 6 · Interventieradiologie en mammaradiologie

De laatste dag van elke stage

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe gebruik je deze gids

Lees de avond voordat je aan een nieuwe stage begint het betreffende hoofdstuk: 15–20 minuten is genoeg.

> *De eerste week van een stage is de week waarin je het meest leert, maar ook het vaakst verdwaalt. Deze gids beantwoordt de vraag «waar begin ik?» voor je.*

Elk stagedeel bestaat uit dezelfde vier onderdelen:

1. **Wat je op de eerste dag moet weten** — hoe de afdeling werkt, wat je van wie moet leren en de basisonderwerpen die je als eerste moet lezen.
2. **De 10 meest voorkomende onderzoeken** — de onderzoeken die je in die stage het vaakst tegenkomt en bij elk ervan waar je eerst naar kijkt.
3. **Typische fouten** — de valkuilen waar eerstejaars AIOS het vaakst in trappen en hoe je ze vermijdt.
4. **Checklist eerste week** — concrete doelen die je aan het eind van de week moet kunnen afvinken.

Bij elk onderzoek dezelfde 4 stappen

1 · VOORBEREIDEN

Identificeer (patiënt, onderzoek, datum, protocol) · Kwaliteit (technische toereikendheid) · Oriënteer (zijde, coupe, venster/sequentie).

2 · DOORLOPEN

Doorloop elk gebied elke keer in dezelfde volgorde. Stop niet bij de eerste bevinding.

3 · BESCHRIJVEN

Met de juiste termen (densiteit / signaal / echogeniciteit), lokalisatie, grootte, begrenzing. Vergelijk met eerder onderzoek en met de andere zijde.

4 · SAMENVATTEN

Conclusie, differentiaaldiagnose, advies. Meld een spoedbevinding direct.

Belangrijk

Op elke afdeling verschillen protocollen, verslagsjablonen en meldroutes. De lijsten in deze gids zijn een algemeen startpunt; leer de regels van je eigen afdeling altijd van je supervisor en pas die toe.

STAGE 1

Neuroradiologie

CT en MRI van de hersenen, wervelkolom, hoofd-hals. Hier wordt de basis gelegd voor het gebied waarvoor je tijdens je dienst het vaakst wordt gebeld.

Wat je op de eerste dag moet weten

- De afdeling **de beoordelingsvolgorde van de hersen-CT** leer en pas bij elk onderzoek hetzelfde toe: bloeding, massa-effect en middenlijn, ventrikels en cisternen, grijze-wittestofdifferentiatie, botvenster, sinussen en mastoïden.
- **De vensters** correct gebruiken: hersenvenster, strokevenster (smal), botvenster; zo nodig het subduraalvenster.
- **Acute beroerte** leer de route: welke onderzoeken (blanco CT, CT-angiografie, perfusie, DWI) je afdeling in welke volgorde vraagt en wie geïnformeerd moet worden.
- Leer de MRI-sequenties herkennen: T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI of GRE, T1 met contrast. Weet wat op elke sequentie helder en wat donker is.
- Leer uit de praktijk van de afdeling welke rol CT speelt bij wervelkolomtrauma en in welke situaties MRI wordt aangevraagd.

De 10 meest voorkomende onderzoeken

#	ONDERZOEK	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**Blanco CT-hersenen (trauma)**	Extra-axiale bloeding, contusie, schedelfractuur (botvenster).
2	**Blanco CT-hersenen (verdenking beroerte)**	Is er een bloeding; vroege tekenen van ischemie, hyperdense-arterieteken.
3	**CT-angiografie (hoofd-hals)**	Occlusie van een groot vat, stenose, dissectie, aneurysma.
4	**MRI-hersenen (routine)**	Witte-stoflaesies, massa, oedeem op FLAIR; restrictie op DWI.
5	**Snelle stroke-MRI met DWI**	Helder op DWI, donker op ADC: passend bij een acuut infarct.
6	**MRI-hersenen met contrast**	Aankleuringspatroon (ring, nodulair, leptomeningeaal, duraal).
7	**CT cervicale wervelkolom**	Uitlijningslijnen, fractuur, facetstand, prevertebrale weke delen.
8	**MRI lumbale wervelkolom**	Discushernia, kanaal- en foraminale stenose, compressie van de cauda equina.
9	**CT van de neusbijholten**	Slijmvliesverdikking, lucht-vloeistofspiegel, botdestructie, orbita.
10	**CT os temporale / orbita**	Botintegriteit, fractuur, densiteit van weke delen, inhoud van de orbita.

Typische fouten

- Door alleen in het hersenvenster te kijken **het botvenster overslaan**; een schedelfractuur missen.

- Een dun subduraal hematoom, een densiteit langs de lamina interna van de schedel, pas in een breed venster opmerken; **niet naar het subduraalvenster overschakelen**.
- Helderheid op DWI als acuut infarct verslaan zonder naar de ADC te kijken (T2-shine-througheffect).
- Massa-effect en middellijnverschuiving als «uitgesproken» beschrijven zonder ze in getallen te meten.
- Niet vergelijken terwijl er eerder onderzoek is.

Checklist eerste week

- [ ] Ik ken mijn beoordelingsvolgorde voor CT-hersenen uit mijn hoofd en pas die bij elk onderzoek op dezelfde manier toe.
- [ ] Ik kan snel wisselen tussen het hersen-, stroke-, subduraal- en botvenster.
- [ ] Ik ken de route van de afdeling voor acute beroerte en spoedmeldingen.
- [ ] Ik herken T1, T2, FLAIR, DWI/ADC en SWI op het beeld.
- [ ] Ik heb minstens 20 blanco CT-hersenen vergeleken met het verslag van mijn supervisor.
- [ ] Ik kan epidurale, subdurale en subarachnoïdale bloeding onderscheiden en beschrijven.
- [ ] Ik heb het hersendeel van Deel 03 · CT en het sequentiedeel van Deel 04 · MRI één keer gelezen.

STAGE 2

Thoraxradiologie

Thoraxfoto, CT-thorax en CT-pulmonalisangiografie. Hier wordt het meest beoordeelde onderzoek gedaan.

Wat je op de eerste dag moet weten

- **Thoraxfoto** een vaste beoordelingsvolgorde vast: techniek (rotatie, inspiratie, penetratie), tubes en katheters, luchtweg, hart en mediastinum, hili, longvelden, pleura en sinussen, onder het diafragma, botten en weke delen.
- Ken het verschil tussen een PA- en een AP-foto: op een AP-foto kan de hartschaduw groter lijken; beoordeel de hartgrootte in het licht van de techniek.
- Op CT-thorax **het long- en mediastinumvenster** afzonderlijk, van begin tot eind.
- Beoordeel bij CT-pulmonalisangiografie eerst of de contrasttiming voldoende is; als die ontoereikend is, vermeld je dat in het verslag.
- Op röntgenfoto's van de intensive care zijn de posities van tubes, katheters en drains het eerste waar je naar kijkt.

De 10 meest voorkomende onderzoeken

#	ONDERZOEK	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**PA-thoraxfoto**	Technische toereikendheid, daarna een vaste beoordelingsvolgorde.
2	**Bedside AP-röntgenfoto (intensive care)**	Endotracheale tube, centrale lijn, maagsonde, drain; pneumothorax.
3	**Laterale thoraxfoto**	Retrosternale en retrocardiale ruimte, posterieure sinussen, wervels.
4	**Blanco CT-thorax**	Nodus, consolidatie, matglas, emfyseem, pleuravocht.
5	**CT-thorax met contrast**	Mediastinale en hilaire lymfeklieren, massa, vasculaire structuren.
6	**CT-pulmonalisangiografie**	Contrastkwaliteit; vullingsdefect in de longslagaders; tekenen van rechterhartbelasting.
7	**Hoge-resolutie-CT (HRCT)**	Interstitieel patroon: reticulatie, honingraat, matglas, tractiebronchiëctasieën.
8	**Lagedosisscreening / follow-up van noduli**	Grootte en structuur van de nodus en verandering ten opzichte van eerder onderzoek.
9	**CT-angiografie thorax (aorta)**	Intimaflap, echt en vals lumen, betrokkenheid van zijtakken.
10	**Echo pleura (zo nodig)**	Aanwezigheid en hoeveelheid van vocht en of er septa zijn.

Typische fouten

- Stoppen zodra je een opvallende bevinding ziet; **de tweede bevinding** (bijv. een botlaesie, lucht onder het diafragma) missen.
- Vergeten dat een pneumothorax op een liggend opgenomen röntgenfoto zich eerder anterieur en basaal dan apicaal kan verzamelen.
- Niet kijken naar «verborgen gebieden» zoals achter de hartschaduw, de hili en de apices.
- Een nodus vinden en follow-up adviseren zonder te vergelijken met eerder onderzoek.
- Een CT-pulmonalisangiografie met ontoereikende contrasttiming als «geen embolie» verslaan.

Checklist eerste week

- [ ] Mijn beoordelingsvolgorde voor de thoraxfoto ligt vast; bij elke foto volg ik dezelfde volgorde.
- [ ] Ik kan de posities van tubes en katheters verslaan zoals de afdeling dat verwacht.
- [ ] Ik kan op de röntgenfoto pneumothorax, pleura-effusie, consolidatie en atelectase onderscheiden.
- [ ] Ik doorloop CT-thorax apart in het long- en het mediastinumvenster.
- [ ] Bij CT-pulmonalisangiografie kijk ik eerst naar de contrastkwaliteit.
- [ ] Ik heb minstens 30 thoraxfoto's vergeleken met het verslag van de radioloog.
- [ ] Ik heb het thoraxdeel van Deel 02 · Röntgen en de thoraxpagina's van de Atlas van de meest voorkomende bevindingen doorgenomen.

STAGE 3

Abdominale radiologie

CT, echo, MRI en röntgenfoto van het abdomen. De stage waarin je het meest bijdraagt aan beslissingen over acute chirurgie.

Wat je op de eerste dag moet weten

- Vaste doorloopvolgorde voor CT-abdomen: vrije lucht en vrij vocht, solide organen (lever, milt, pancreas, nieren, bijnieren), galwegen, darmen en mesenterium, vaten, lymfeklieren, bekken, botten, longbases.
- **De contrastfasen** herken (arterieel, portaal-veneus, laat) en leer uit het afdelingsprotocol welke fase bij welke klinische vraag gevraagd wordt.
- Maak er een gewoonte van over te schakelen naar het long- of een breed venster om naar vrije lucht te zoeken.
- Leer bij echo-abdomen de standaardcoupes van het rechterbovenkwadrant, de nieren en het bekken.
- Leer de meldroute op je afdeling voor spoedbevindingen bij een acute buik (zoals vrije lucht, actieve bloeding, tekenen van ischemie, closed-loop-obstructie).

De 10 meest voorkomende onderzoeken

#	ONDERZOEK	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**CT abdomen-bekken met contrast (portaal-veneus)**	Vrije lucht, vrij vocht, solide organen, darmwand.
2	**Blanco CT (stenenprotocol)**	Stenen in de urinewegen, hydronefrose, perirenaal vetweefsel.
3	**Echo-abdomen (rechterbovenkwadrant)**	Galstenen, wanddikte, pericholecystisch vocht, diameter van de galwegen.
4	**Echografie van de urinewegen**	Hydronefrose, niergrootte en parenchym, blaas.
5	**Staande buikoverzichtsfoto**	Vrije lucht onder het diafragma, lucht-vloeistofspiegels, darmdiameters.
6	**CT of echo bij verdenking op appendicitis**	Diameter van de appendix, wand, omgevend vetweefsel, appendicoliet, abces.
7	**Trauma-CT**	Letsel van solide organen, actieve contrastextravasatie, vrij vocht.
8	**Dynamische CT/MRI van de lever**	Het aankleuringsgedrag van de laesie per fase.
9	**MRCP**	Vullingsdefect in de galwegen, stenose, ductus pancreaticus.
10	**Echo / MRI van het bekken**	Structuren van ovaria en uterus, vrij vocht, massa.

Typische fouten

- Alleen in het weke-delenvenster kijken en **vrij lucht** missen.

- Je focussen op de hoofdbevinding en **de longbases** en de botten niet doorlopen.
- Een niersteen vinden en stoppen zonder de andere zijde en de blaas te beoordelen.
- Bij een onderzoek op appendicitis niet zoeken naar alternatieve diagnoses (diverticulitis, ovariumpathologie, ureterolithiasis).
- Een laesie beschrijven zonder de contrastfase te vermelden.

Checklist eerste week

- [ ] Mijn doorloopvolgorde voor CT-abdomen ligt vast en is bij elk onderzoek hetzelfde.
- [ ] Ik herken de arteriële, portaal-veneuze en late fase op het beeld.
- [ ] Bij elk onderzoek schakel ik over naar een breed venster om naar vrije lucht te zoeken.
- [ ] Ik kan de standaardcoupes van de echo van het rechterbovenkwadrant maken.
- [ ] Ik ken de spoedmeldroute bij een acute buik.
- [ ] Ik heb minstens 15 CT-abdomens vergeleken met het verslag van mijn supervisor.
- [ ] Ik heb het abdomendeel van Deel 03 · CT en het deel over het rechterbovenkwadrant van Deel 05 · Echo/POCUS gelezen.

STAGE 4

Musculoskeletale radiologie

Traumaröntgenfoto's, MRI van gewrichten en botlaesies. Wie niet systematisch kijkt, mist zelfs de makkelijkste fractuur.

Wat je op de eerste dag moet weten

- **Bij elke traumaröntgenfoto minstens twee loodrechte richtingen** nodig is en dat één vlak een fractuur kan verbergen.
- Beoordelingsvolgorde voor botfoto's: integriteit van de cortex, gewrichtsstand, gewrichtsspleet, botweefsel (densiteit en structuur), weke delen (zwelling, vetkussens, lucht).
- Leer de volgorde om een fractuur te beschrijven: bot en regio, richting van de fractuurlijn, aantal fragmenten, verplaatsing en angulatie, gewrichtsbetrokkenheid.
- Leer de basissequenties bij MRI van gewrichten (vetonderdrukte PD/T2, T1) en welke structuur op welke sequentie het best te zien is.
- Systematische benadering van een botlaesie: locatie, begrenzing (overgangszone), periostreactie, matrix, wekedelencomponent.

De 10 meest voorkomende onderzoeken

#	ONDERZOEK	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**Röntgenfoto pols**	Distale radius, scafoïd, uitlijning van de carpus.
2	**Röntgenfoto enkel**	Malleoli, enkelvork, talus.
3	**Röntgenfoto heup en bekken**	Cortex van de femurhals, integriteit van de bekkenring.
4	**Röntgenfoto schouder**	Verhouding tussen humeruskop en glenoïd, fractuur, luxatie.
5	**Röntgenfoto knie**	Tibiaplateau, effusie, gewrichtsspleet.
6	**MRI-knie**	Menisci, kruisbanden, beenmergoedeem, kraakbeen.
7	**MRI-schouder**	Pezen van de rotator cuff, labrum, bicepspees.
8	**Trauma-CT (bekken, wervelkolom, intra-articulaire fractuur)**	Verloop van de fractuurlijn, aantal fragmenten, gewrichtsvlak.
9	**Röntgenfoto lumbale / thoracale wervelkolom**	Wervelhoogte, alignment, integriteit van de pedikels.
10	**Beoordeling van een botlaesie (röntgenfoto, CT of MRI)**	Overgangszone, periostreactie, matrix, wekedelencomponent.

Typische fouten

- Eén fractuur vinden en **de tweede fractuur** of niet naar een bijkomende luxatie zoeken.

- Zoals het scafoïd en de femurhals **bij fracturen die verborgen kunnen blijven** bij een normale röntgenfoto niet aan aanvullend onderzoek of een follow-upadvies denken.
- De weke-delenbevindingen (vetkussentjesteken, gewrichtseffusie) niet beoordelen.
- Een posterieure schouderluxatie missen op één richting.
- Een botlaesie met één woord («lytisch») afdoen zonder systematische beschrijving.

Checklist eerste week

- [ ] Bij elke traumaröntgenfoto controleer ik twee richtingen.
- [ ] Ik pas mijn beoordelingsvolgorde voor botfoto's toe (cortex, uitlijning, gewricht, bot, weke delen).
- [ ] Ik kan een fractuur beschrijven in de volgorde die de afdeling verwacht.
- [ ] Ik kan bij een MRI van de knie de menisci en kruisbanden sequentie voor sequentie beoordelen.
- [ ] Ik heb de systematische benadering van een botlaesie bij één casus van begin tot eind toegepast.
- [ ] Ik heb minstens 30 traumaröntgenfoto's vergeleken met het verslag van de radioloog.
- [ ] Ik heb het musculoskeletale deel van Deel 02 · Röntgen en de bijbehorende checklist in de Gids voor beeldinterpretatie doorgenomen.

STAGE 5

Kinderradiologie

Een kind is geen kleine volwassene: andere anatomie, andere ziekten en meer zorg rond straling.

Wat je op de eerste dag moet weten

- **Principe van stralingsbescherming** heeft bij kinderen voorrang: kies zo mogelijk een methode zonder straling (echo, MRI); is CT nodig, dan wordt het pediatrisch protocol van de afdeling gebruikt.
- Groeischijven, ossificatiekernen en leeftijdsafhankelijke normale aspecten kunnen met een fractuur worden verward; bij twijfel **vergelijking met de andere kant** en het gebruik van een atlas worden per afdeling beoordeeld.
- Ken het brede gebruik van echo in de kinderradiologie: zoals invaginatie, appendicitis, pylorus, heup en schedelecho.
- Als je bij een kind een onverklaarde fractuur, fracturen in verschillende stadia of bevindingen die niet bij de anamnese passen ziet, volg dan op de afdeling **de meldroute voor kindermishandeling** samen met je supervisor bekijken.
- Leer hoe onderzoeken die sedatie en voorbereiding vereisen op de afdeling verlopen.

De 10 meest voorkomende onderzoeken

#	ONDERZOEK	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**Thoraxfoto bij kinderen**	Techniek, thymusschaduw, consolidatie, air trapping, corpus alienum.
2	**Echo-abdomen (buikpijn)**	Appendix, invaginatie, vrij vocht, lymfeklieren.
3	**Röntgenfoto elleboog**	Vetkussentjes, ossificatiekernen, supracondylaire fractuur.
4	**Röntgenfoto van onderarm en pols**	Torus- en greenstickfracturen, groeischijf.
5	**Echo heupen (zuigeling)**	Verhouding tussen acetabulum en femurkop, de meetmethode van de afdeling.
6	**Echografie van de urinewegen**	Hydronefrose, niergrootte, blaaswand.
7	**Schedelecho (pasgeborene)**	Ventrikelgrootte, bloeding, echogeniciteit van het parenchym.
8	**Echo pylorus**	Dikte van de pylorusspier en lengte van het kanaal (volgens de criteria van de afdeling).
9	**Buikoverzichtsfoto**	Verdeling van darmgas, obstructie, corpus alienum.
10	**Blanco CT-hersenen (trauma)**	Bloeding, fractuur; of de indicatie voldoet aan de regels van de afdeling.

Typische fouten

- Een normale groeischijf of ossificatiekern **voor een fractuur aanzien**, of andersom.
- Het vetkussenteken op de röntgenfoto van de elleboog zien en niet aan een occulte fractuur denken.

- Een normale thymusschaduw interpreteren als mediastinale massa.
- Bij een vraag die met echo te beantwoorden is reflexmatig een CT voorstellen.
- Een bevinding die niet bij de leeftijd of de anamnese past alleen beschrijven en niet aan de meldroute denken.

Checklist eerste week

- [ ] Ik ken het pediatrische CT-protocol en de stralingsbeschermingsregels van de afdeling.
- [ ] Ik kan op de röntgenfoto van de elleboog de volgorde van de ossificatiekernen en de vetkussens beoordelen.
- [ ] Ik kan torus-, greenstick- en groeischijffracturen beschrijven.
- [ ] Ik heb minstens een paar keer meegekeken bij een echo-abdomen voor appendix en invaginatie.
- [ ] Ik heb de meldroute voor kindermishandeling van mijn supervisor geleerd.
- [ ] Ik heb voorbeelden gezien van een normale thymus, een normale groeischijf en normale varianten.
- [ ] Ik heb de betreffende delen van Deel 05 · Echo/POCUS en Deel 02 · Röntgen doorgenomen.

STAGE 6

Interventieradiologie en mammaradiologie

Twee verschillende werelden, één gemeenschappelijke regel: voorbereiding vóór de ingreep en het verslaan van het beeld in de juiste taal.

Wat je op de eerste dag moet weten

INTERVENTIERADIOLOGIE

- Controle vóór de ingreep: indicatie, eerdere beelden, toestemming, door de afdeling gevraagde laboratorium- en medicatiecheck (de beslissing ligt bij je supervisor).
- Regels voor het steriele veld, stralingsbescherming (loodschort, schildklierkraag, afstand, tijd) en gebruik van de dosimeter.
- Leer de meest voorkomende ingrepen kennen: echo- of CT-geleide biopsie, drainage van abcessen en vochtcollecties, percutane nefrostomie, centraal veneuze toegang, angiografie.
- Leer de checklist van de afdeling voor de follow-up van de patiënt na de ingreep.

MAMMARADIOLOGIE

- Leer de standaardopnamen van de mammografie (CC en MLO) herkennen; vergelijk beide borsten symmetrisch.
- Bij het verslaan **het standaard classificatiesysteem** en leer de terminologie die je afdeling gebruikt; schrijf de categorie en het advies samen op.
- Ken de basiskenmerken die bij echo van de borst een cyste van een solide laesie onderscheiden: vorm, begrenzing, inwendige structuur, dorsale akoestische kenmerken.
- Vergelijking met eerdere mammografieën is in de mammaradiologie bijzonder belangrijk.

De 10 meest voorkomende onderzoeken en ingrepen

#	ONDERZOEK / INGREEP	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
1	**Screeningsmammografie**	Symmetrie, massa, verkalking, architectuurverstoring; vergelijking met eerder onderzoek.
2	**Diagnostische mammografie**	Locatie van de klinische bevinding; behoefte aan aanvullende beeldvorming.
3	**Echo mammae**	Cysteus of solide; vorm, begrenzing, oriëntatie, dorsale akoestische kenmerken.
4	**Echogeleide mammabiopsie**	Doellaesie, naaldbaan, toereikendheid van het monster.
5	**Echogeleide biopsie van de schildklier of een lymfeklier**	Doel, omliggende vaten, veilige baan.

#	ONDERZOEK / INGREEP	WAAR JE EERST NAAR KIJKT
6	**CT-geleide biopsie**	Doel en een veilige naaldbaan; relatie met pleura en vaten.
7	**Abces-/vochtdrainage**	Grootte en inhoud van de collectie, veilige toegangsweg.
8	**Percutane nefrostomie**	Mate van hydronefrose, toegangsweg naar de nier.
9	**Centraal veneuze toegang / port**	Doorgankelijkheid van het vat (echo), positie van de tip (doorlichting of röntgenfoto).
10	**Diagnostische angiografie**	Toegangsplaats, vaatanatomie, stenose of bloedingsbron.

Typische fouten

- Aan een ingreep beginnen zonder de eerdere beelden te bekijken.
- Stralingsbeschermingsmiddelen en de dosimeter verwaarlozen.
- Op de mammografie naar één borst kijken en **symmetrievergelijking** niet doen.
- In een mammaverslag een categorie noemen zonder een duidelijk advies te geven.
- In het verslag van de ingreep de gebruikte methode, het aantal samples en het al dan niet optreden van complicaties niet vermelden.

Checklist eerste week

- [ ] Ik ken de checklist van de afdeling vóór een ingreep en pas die toe.
- [ ] Ik gebruik bij elke ingreep mijn stralingsbeschermingsmiddelen en mijn dosimeter.
- [ ] Ik heb bij minstens 3 echogeleide ingrepen meegekeken en de stappen genoteerd.
- [ ] Ik herken CC- en MLO-opnamen en vergelijk beide borsten symmetrisch.
- [ ] Ik heb de standaardcategorieën en adviezen bij het verslaan van de borst geleerd.
- [ ] Ik kan bij echo van de borst een cyste en een solide laesie beschrijven.
- [ ] Ik heb Deel 05 · Echo/POCUS en de betreffende casussen in Deel 06 · Multimodale casussen doorgenomen.

AFSLUITING

De laatste dag van elke stage

Een afsluiting van 20 minuten bij de overgang van de ene stage naar de volgende zorgt dat wat je hebt geleerd blijft hangen.

1. **Ga terug naar de checklist.** Noteer de punten die je niet kon afvinken voor de eerste week van de volgende stage.
2. **De 5 onderzoeken waar je het meest moeite mee hebt** Schrijf in het Oefenboek: wat je hebt gemist, waarom je het hebt gemist en wat je de volgende keer doet.
3. **Vraag je supervisor om korte feedback:** «Wat moet ik tijdens deze stage beter doen?»
4. **Het deel van de volgende stage** één keer in deze gids.
5. **in het Studieprogramma voor een stage van 12 weken** pas de volgende week aan je nieuwe stage aan.

> **Gouden regel**
>
> Stel bij elke stage dezelfde vraag: «Kan ik tijdens mijn dienst een onderzoek uit dit gebied alleen en veilig beoordelen?» Is het antwoord «nog niet», zet dan wat ontbreekt op de checklist.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu het hoofdstuk van je huidige stage en print de checklist voor de eerste week.

Daarna **Sjablonen voor casuspresentaties tijdens de visite**: ga daarnaar verder – daar vind je hoe je de casussen uit je stage tijdens de visite in 60 of 120 seconden presenteert.